

NOTA DINAS

Dari : apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
Kepada : dr. Resti Lestantini, M.Kes.
Direktur RS Prima Husada Malang
Perihal : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Tanggal : 02 Juni 2026

Isi Nota Dinas : Materi terkait Optimalisasi Program Rujuk Balik

Dasar : Optimalisasi Program Rujuk Balik
Maksud & Tujuan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) di wilayah Malang Raya
Waktu : Selasa, 02 Juni 2026 12.00 – 15.00
Pelaksanaan :
Nama Petugas : apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
Nur Rizkiah Amalia
Daerah Tujuan / Instansi yang Dikunjungi : Ruang Lotus, Javanine 2 Resto Cemara
Hadir Dalam Pertemuan : Iya
Petunjuk / Arahan yang Diberikan (Materi) :
1. Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka Panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat. Cakupan penyakit kronis PRB terdiri dari Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, PPOK, Epilepsy, Schizophrenia, SLE, dan Stroke. Kepatuhan peresepan obat PRB berdasarkan peraturan perundangan PRB yang telah disesuaikan dapat dilihat dan di cek melalui website
2. Alur Pelayanan Peserta PRB
- Peserta dari puskesmas/klinik dengan riwayat 3 bulan diagnose PRB dengan sediaan obat yang sama
- Peserta di daftarkan masuk ke dalam Data Potensi PRB
- IFRS memberikan Surat Rujuk Balik (SRB) dan obat dengan resep selama 7 hari
- Peserta diminta ke FKTP untuk pengambilan obat 23 hari
- Dokter FKTP menuliskan resep/mempersuasi potensi PRB untuk PRB
- Apotek PRB memberikan obat 23 hari. (Apotek PRB mengirim obat ke FKTP melalui kurir sehingga pasien sudah tidak lagi mengambil di Apotek namun di FKTP
Jika obat di RS kosong, maka SRB juga harus diganti (konsul dengan DPJP), dan jika terdapat kekosongan obat nasional maka harus dilaporkan ke apotek online.
3. Capaian peserta PRB Aktif masih rendah meskipun proses PRB telah berjalan.
Status PRB Aktif mensyaratkan adanya kontak peserta dengan FKTP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disepakati pelaksanaan program **Jemput Bola Pasien PRB** melalui kolaborasi FKRTL, FKTP, dan Apotek Jejaring. Akan ada Link Spreadshet dan grup untuk PIC 3 instansi diatas :

- Diisi oleh FKRTL (nama FKTP, nama peserta, nomor kartu, nomor HP, diagnose/program rujuk balik, nama DPJP, data obat + signa, tanggal pengambilan, jumlah obat yang diterima
 - Diisi oleh FKTP (tanggal FKTP kontak dengan pasien, tanggal rencana berkunjung, tanggal berkunjung pasien, nomor kunjungan -> setelah kontak dengan pasien yang di PRB
 - Diisi oleh Apotek PRB (obat sudah tersedia/belum, tanggal apotek delivery ke FKTP, data obat+signa)
3. Sistem pasien yang di PRB yaitu harus stabil dari semua penyakit, jika ada pasien dengan dua DPJP maka diberlakukan rujuk internal dengan menggabungkan obat pasien menjadi satu dan dapat di PRB jika keduanya sudah stabil. Pasien yang tidak dapat diPRB kan hanya pasien yang mendapatkan rujukan ke 2 DPJP dengan kategori penyakit kronis. Untuk penginputan SRB pada V-Claim maka dimasukkan salah satu dari penyakit kategori PRB dan obat yang diinputkan adalah semua obat dari gabungan diagnosa yang masuk ke dalam kategori PRB. Jika ada obat yang masuk dalam FORNAS PRB tetapi tidak muncul dalam Vclaim SRB maka bisa ditambahkan secara manual di lembar SRB.

Masalah / Temuan di RS PHM yang Relevan dengan Materi	:	Masih ditemukan pasien yang disarankan PRB namun terdapat rujukan di poli lain atau DPJP lain kronis yang belum stabil
Saran / Tindakan untuk RS hasil dari Pelatihan	:	- Sosialisasi kepada semua poli, DPJP, dan farmasi untuk tidak memberikan PRB kepada pasien dengan diagnosa dan penyakit yang di rujuk ke 2 DPJP - Dilakukan pemberian rujuk internal jika pasien didapatkan penyakit lain yang diharuskan dirujuk kepada DPJP selain diagnose utama dan pemberian resep dengan menggabungkan obat kedua penyakit kronis kategori PRB dalam satu resep - Optimalisasi pasien dengan tanda Potensi PRB (apabila sudah bridging SIMRS dengan APOL maka data dapat ditarik sehingga bisa menjadi alata bantu DPJP untuk PRB pasien yang stabil)

Nama Karyawan : apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm

Tembusan : Direktur RS Prima Husada Malang



DOKUMENTASI

